拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５７０６３
起案日	令和　８年　１月２６日
特許庁審査官	倉持　俊輔　　３２０９　２Ｊ００
特許出願人代理人	小林　浩（ほか　３名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第２９条第１項柱書（非利用）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

記

●理由１（明確性）について

（１）

請求項１に記載の「（ａ）参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値が、前記対象を、前記治療からの利益を得る可能性が高いことを特定し、前記治療が、がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含むか、または（ｂ）参照値よりも小さい値が、前記対象を、前記治療からの利益を得る可能性が高いことを特定し、前記治療が、がん免疫療法を用いない標的治療を含む」において、「または」の意味内容が不明瞭である。

すなわち、「または」が（ａ）と（ｂ）とを択一的に選択する、したがって（

ａ）と（ｂ）のいずれかが発明特定事項となるという意味なのか、「（ａ）参照値よりも大きいかまたはそれに等しい」場合と「（ｂ）参照値よりも小さい」場合とに場合分けする、したがって（ａ）も（ｂ）も場合により発明特定事項となるという意味なのか、いずれを意味しているのかが不明瞭である。
　請求項３，５についても同様である。
　したがって、請求項１，３，５及びこれらに従属する請求項２，４，６-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（２）
　請求項１に記載の（ａ）における「参照値」と（ｂ）における「参照値」とが、同じ「参照値」なのか否かが不明瞭である。
　請求項３，５，２６についても同様である。
　したがって、請求項１，３，５，２６及びこれらに従属する請求項２，４，６-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（３）
　請求項２に記載の「治療からの利益の増加」及び「治療からの利益の実質的な増加」において、「増加」とは何に対する「増加」を意味しているのかが不明である。
　したがって、請求項２及びこれに従属する請求項４-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（４）
　請求項４に記載の「前記対象が・・・選択される」ことの意味内容が不明確である。
　請求項１に記載された発明は「治療から利益を得る可能性が高いがんを有する対象を特定する方法」であるが、「前記対象が・・・選択される」ことと、「対象を特定する」こととがどのような関係であるのか不明瞭である。「選択」が「特定」に先立つのか、「特定」が「選択」に先立つのか、「選択」と「特定」が同じことを指すのか、いずれを意味するのか明確でない。
　請求項３に記載された発明は「治療をがんを有する対象のために選択する方法」であるが、「前記対象が・・・選択される」ことと、「治療を・・・選択する」こととの関係が上記と同様に不明瞭である。
　したがって、請求項４及びこれに従属する請求項６-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（５）
　請求項５には「・・・方法を含む治療において使用するための・・・医薬組成物であって、前記方法が・・・を含む方法。」と記載されており、発明の属する

カテゴリーが「物」（医薬組成物）であるのか、「方法」であるのか、いずれであるかが不明確である。
　したがって、請求項５及びこれに従属する請求項６－２５に係る発明の範囲は不明確である。

（６）
　請求項５に記載の「値を受けて」の意味内容が不明瞭である。
　「値を受け」るとは、値を具体的に取得したり受信したりすることを意味するのか、それとも単に値を考慮することを意味するのか、いずれを意味するのか明確でない。
　したがって、請求項５及びこれに従属する請求項６－２５に係る発明の範囲は不明確である。

（７）
　請求項６には「請求項１から４のいずれか一項に記載の方法、または請求項５に記載の医薬組成物」が記載されているが、発明の属するカテゴリーが「物」（医薬組成物）であるのか、「方法」であるのか、いずれであるかが不明確である。
　請求項７－２５についても同様である。
　したがって、請求項７－２５に係る発明は不明確である。

（８）
　請求項７に記載の「前記値が（ａ）以下より大きいかもしくはそれに等しい・・・または（ｂ）以下より小さい」の意味内容は、請求項７に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」と請求項１，３，５に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」との関係が不明であるため、不明瞭である。
（例えば、前記「参照値」を特定する記載に置き換えることを、検討されたい。）

（９）
　請求項８には「前記値を取得するステップ」と記載されているが、請求項５に従属する請求項６または７を引用する場合には、「前記値を取得するステップ」が何を指すのか不明である。
　したがって、請求項８及びこれに従属する請求項９－２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１０）
　請求項１１には、「治療からの利益を得る可能性が高いことをさらに特定する」ことが記載されているが、請求項３に従属する場合、請求項３に係る発明は、

治療を選択する方法であるところ、治療を選択することとの関係が不明瞭である。
　同様に請求項５に従属する場合、請求項５に係る発明は、医薬組成物を対象に投与するステップを含む方法を含む治療において使用するための、医薬組成物であるところ、医薬組成物を対象に投与するステップとの関係が不明瞭である。
　請求項１２，１４-１５についても同様のことをいうことができる。
　したがって、請求項１１-１２，１４-１５及びこれらに従属する請求項１３，１６-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１１）
　請求項１２に記載の「または」は上記（１）と同様に、択一的な選択肢を示すのか、場合分けを示すのか、いずれを意味するのか明確でない。
　請求項１４についても同様のことをいうことができる。
　したがって、請求項１２，１４及びこれらに従属する請求項１３，１５-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１２）
　請求項１３に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」の値と、請求項１２に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」との関係が不明である（なお、請求項１２に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」と無関係であれば、請求項13に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」の値のいずれかは必ず満たされるので、何も特定していないことに注意されたい。）。
　したがって、請求項１３及びこれに従属する請求項１４-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１３）
　請求項１６に記載の「前記治療から利益を得る可能性の高い対象、または前記治療からの利益の増加を有する可能性の高い対象」は、請求項３，５に従属する場合、何を指すのか不明瞭である。
　したがって、請求項１６及びこれに従属する請求項１７-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１４）
　請求項１７に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」の値と、請求項１６に記載の「（ａ）」及び「（ｂ）」との関係が不明である。
　したがって、請求項１７及びこれに従属する請求項１８-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１５）

請求項１８には「（ａ）前記対象が、標的治療で処置されたか、または処置されている」という選択肢と、「（ｂ）前記対象が、標的治療で処置されなかったか、または処置されていない」という選択肢とが「または」で並列して記載されている。
しかしながら、対象が標的治療で処置されたか、処置されなかったかが不明であったとしても、いずれかの選択肢は必ず満たされるはずである（「ＡであるまたはＡでない」という命題は常に「真」である。）から、請求項１８の上記記載は何を特定しているのか、その技術的意味が不明である。
請求項１８に記載の選択肢（ｃ）または（ｄ）、及び選択肢（ｅ）または（ｆ）についても同様のことをいうことができる。
請求項２２の選択肢（ｂ）と（ｄ）についても同様のことをいうことができる。
したがって、請求項１８,２２及びこれらに従属する請求項１９-２１，２３-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１６）
請求項２１の記載の「約３００ｍｇ～４００ｍｇ」において、「約」の基準ないし程度が不明瞭である。
したがって、請求項２１及びこれに従属する請求項２２-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１７）
請求項２２に記載の（ａ）から（ｇ）の項目が、「および」で並列されているのか、「または」で並列されているのか、不明である。
したがって、請求項２２及びこれに従属する請求項２３-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１８）
請求項２３に記載の「さらなる治療の投与のために前記対象がさらに選択される」ことの意味内容が不明確である。
「治療の投与」において、「治療」がどのような治療なのか不明であるため、「投与」されることの意味内容が不明瞭である。
「前記対象がさらに選択される」ことが、請求項１に記載の「対象を特定する」こととの関係が不明瞭である。同様に、請求項３に記載の「治療を」「選択する」こととの関係も、請求項５に記載の「対象を処置する方法を含む治療において使用するための、標的治療剤を含む医薬組成物」との関係も不明瞭である。
したがって、請求項２３及びこれに従属する請求項２４-２５に係る発明の範囲は不明確である。

（１９）
　請求項２４に記載の「前記治療」が、請求項２３に記載の「治療」を指すのか、請求項１，３，５にそれぞれ記載の「治療」を指すのか、いずれを指すのか不明瞭である。
　したがって、請求項２４及びこれに従属する請求項２５に係る発明の範囲は不明確である。

（２０）
　請求項２５に記載の「前記方法が、ＴＩＬ、ＰＤ-Ｌ１、ＣＤ８、ＩＦＮγ、またはＴ細胞炎症遺伝子発現シグネチャーを含む免疫活性化のレベルおよび／または活性の値を取得するステップをさらに含む」ことの意味内容が不明確である。
　請求項２５が従属する請求項５には「がんを有する対象を処置する方法」が記載されているところ、「がんを有する対象を処置する方法」が、対象の処置と直接関わらない「ＴＩＬ、ＰＤ-Ｌ１、ＣＤ８、ＩＦＮγ、またはＴ細胞炎症遺伝子発現シグネチャーを含む免疫活性化のレベルおよび／または活性の値を取得するステップをさらに含む」ことの意味内容が不明瞭である。
　したがって、請求項２５に係る発明の範囲は不明確である。

（２１）
　請求項２６に記載の「参照値よりも小さい値を有する対象」及び「参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値を有する対象」において、何が「参照値よりも小さい値」や「参照値よりも大きいかまたはそれに等しい値」なのか、その主語が明確でない（「取得した前記値が」ではないか？）。
　したがって、請求項２６に係る発明の範囲は不明確である。

●理由２（サポート要件）について
（１）
　請求項１には「対象からの試料中のＣＤ８＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性に対するＣＤ４＋免疫エフェクター細胞のレベルまたは活性の値」に応じて、「対象」が、「がん免疫療法と組み合わせて標的治療を含む」「治療からの利益を得る可能性が高い」こと、又は「がん免疫療法を用いない標的治療を含む」「治療からの利益を得る可能性が高い」ことを「特定する」旨が記載されている。
　これに対し、発明の詳細な説明（特に、明細書［０４６９］-［０４７９］，［０５１０］等を参照。）には、切除不能または転移性のＢＲＡＦ　Ｖ６００変異皮膚黒色腫が確認された成人患者を、スパルタリズマブとダブラフェニブおよびトラメチニブによる併用療法（ｓｐａｒｔａ-ＤａｂＴｒａｍによる処置）を受ける治療アームと、スパルタリズマブ適合プラセボとダブラフェニブおよびト

ラメチニブによる併用療法（プラセボーＤａｂＴｒａｍによる処置）を受ける対照アームに１：１で無作為化し、フローサイトメトリーによる末梢血ヘルパーＴ細胞／細胞障害性Ｔ細胞比（ＣＤ４＋／ＣＤ８＋）を評価したところ、ベースライン時のＣＤ４＋／ＣＤ８＋比が中央値２．９以上の患者では、ｓｐａｒｔａ-ＤａｂＴｒａｍによる処置は、プラセボーＤａｂＴｒａｍによる処置と比較して無憎悪生存期間を改善したことが記載されている。
　しかしながら、本願出願時における技術常識に照らしても、「黒色腫」以外の「がん」を有する「対象」において、「治療からの利益を得る可能性が高い」か否かは不明である。
　また、「がん免疫療法と組み合わせ」た「標的治療」として、ＰＤ-１またはＰＤ-Ｌ１結合アンタゴニスト（スパルタリズマブ）とＢＲＡＦを標的とする薬剤（ダブラフェニブ）及びＭＥＫを標的とする薬剤（トラメチニブ）との併用療法以外により、「治療からの利益を得る可能性が高い」か否かは不明である。
　請求項３，５，２６についても同様のことをいうことができる。
　したがって、請求項１，３，５，２６及びこれらに従属する請求項２，４，６-２５に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した事項から一般化ないし拡張することができる範囲を超えているから、発明の詳細な説明に記載したものでない。

（２）
　請求項１は「参照値よりも小さい値を有すると特定された前記対象が、前記治療からの利益を得る可能性が高いことを特定し、前記治療が、がん免疫療法を用いない標的治療を含む」ことが記載されている。
　しかしながら、発明の詳細な説明に記載されたプラセボーＤａｂＴｒａｍによる処置（がん免疫療法を用いない標的治療）については、ベースライン時のＣＤ４＋／ＣＤ８＋比が参照値（中央値）より小さいからといって、無憎悪生存期間の延長等の治療の利益を得られることは記載されていない。
　請求項２６についても同様のことをいうことができる。
　したがって、請求項１，２６及びこれらに従属する請求項２，４，６-２５に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した事項から一般化ないし拡張することができる範囲を超えているから、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由３（産業上の利用可能性）について
・請求項１-４，６-２６
　請求項１に記載の「治療から利益を得る可能性が高いがんを有する対象を特定する方法」は、人間を含む「対象」について、「治療から利益を得る可能性が高いがんを有する」という身体状態について、判断する（特定する）ことを含むため、人間を診断する方法に該当する。
　請求項３に記載の「治療をがんを有する対象のために選択する方法」は、人間

を含む「対象」について、身体状態に基づいて「治療を」「選択する」という治療計画について判断する（選択する）ことを含むため、人間を診断する方法に該当する。
　請求項２６に記載の「がんを有する対象を第１の群と第２の群に層別化する方法」は、人間を含む「対象」を、「治療からの利益を得る可能性」という身体状態について、判断する（第１の群と第２の群に層別化する）ことを含むため、人間を診断する方法に該当する
　したがって、請求項１，３，２６及びこれらに従属する請求項２，４，６-２５に係る発明は、産業上の利用可能性を満たさない。
（請求項１については、例えば、「治療から利益を得る可能性が高いがんを有する対象を特定するための方法」等と記載すれば、この限りでない。）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／５３，３３／５７４，
　　ＣＡＰｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＹ（ＳＴＮ）
・先行技術文献　国際公開第２０２１／０２５０３１号
　　特表２０１７-５３６８４２号公報
　　米国特許出願公開第２０２０／０３７１０９１号明細書
　　米国特許出願公開第２０１１／００９１４８１号明細書

Reinhard DUMMER et al., Combined PD-1, BRAF and MEK inhibition in advanced BRAF-mutant melanoma: safety run-in and biomarker cohorts of COMBI-i, nature medicine, 2020年10月, Vol.26, pp.1557-1563

Charlotte E ARIYAN et al., Robust Antitumor Responses Result from Local Chemotherapy and CTLA-4 Blockade, Cancer Immunology Research, 2018年2月, Vol.6, No.2, pp.189-200

Chad TANG et al., Ipilimumab with Stereotactic Ablative Radiation Therapy: Phase I Results and Immunologic Correlates from Peripheral T Cells, Clinical Cancer Research, 2017年3月15日, Vol.23, No.6, pp.1388-1396

Eddie Fernando Candido MURTA et al., LYMPHOCYTE SUBPOPULATIONS IN PATIENTS WITH ADVANCED BREAST CANCER SUBMITTED TO NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY, Tumori Journal, 2000年9月, Vol.86, pp.403-407

Miren ZUAZO et al., Systemic CD4 Immunity as a Key Contributor to PD-L1/PD-1 Blockade Immunotherapy Efficacy, frontiers in Immunology, 2020年11月30日, Vol.11, Article No.586907

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事

前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　倉持　俊輔（くらもち　しゅんすけ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５０
※○○○○@jpo.go.jp（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	倉持　俊輔	
３６１１	３２０９	